11. LE COEUR RÉSUMÉ ET IMPLICATION PRATIQUE

DURÉE : 11:02 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore l'importance du cœur dans le développement embryonnaire, en le positionnant comme le point de rencontre des forces vitales entre le spermatozoïde et l'ovule. On y apprend comment le cœur se forme au sein de la ligne primitive, interagissant avec des structures clés comme le tube neural et le mésoderme. Les concepts de diastole et systole sont également abordés, avec une attention particulière à la façon dont ces mouvements peuvent être observés et intégrés dans la pratique ostéopathique. Les praticiens apprendront à utiliser des fulcrums embryonnaires pour revitaliser et équilibrer les systèmes cardiaques et cérébraux, en affinant leur approche au travers de points d'appui pertinents.

LE CŒUR : RÉSUMÉ ET IMPLICATIONS PRATIQUES

LE CŒUR : POINT DE RENCONTRE SYMBOLIQUE

Le **cœur** est considéré comme le point de rencontre symbolique entre le **spermatozoïde** et l'**ovule**. C'est ici que se met en place un **pattern fondamental**, se manifestant même sur un plan de polarité.



FIG. — Embryon bicellulaire

APPARITION ET DÉVELOPPEMENT PRÉCOCE

L'émergence du cœur est particulièrement intéressante au niveau de la **ligne primitive**.

C'est le vestige sous S2, extrémité terminale de la **notochorde** et lieu de la sensation.

Nous l'abordons dans son environnement facial et son mouvement développemental. Il réintégrera la **neurulation secondaire** lors de la fermeture et de la mise en place du petit bassin.

La neurulation secondaire est cet espace entre le **filum terminal** et le **bourgeon caudal**, impliquant une croissance différentielle du **tube neural** par rapport à l'**endoblaste** antérieur, avec une ouverture de la lumière.

L'endoblaste antérieur est l'endoblaste embryonnaire, mais ici, au niveau **mésoblastique** et également au niveau du cœur.

Dans cette vague avec la ligne primitive, qui se termine en S2, une **force cardiaque primitive** est déjà présente. La localisation présumée dans l'épiblaste fait partie du potentiel du cœur, c'est la localisation la plus précoce identifiée.

Les **cellules cardiogéniques** se trouvent au niveau de l'épiblaste, dans la couche présomptive de l'épiblaste, avant même la formation du mésoderme.

Nous retrouverons cette lame présomptive. Un mouvement de croissance est suivi d'une congestion, puis de l'intégration et de la rencontre des deux tubes, organisée depuis la périphérie par la **cavité amniotique**. Le tube neural, le tube cardiaque, et l'intégration du diaphragme concourent à la mise en place du cœur.

Ceci se produit au même moment que la fermeture du tube neural et l'intégration du **cœlome** externe en cœlome interne.

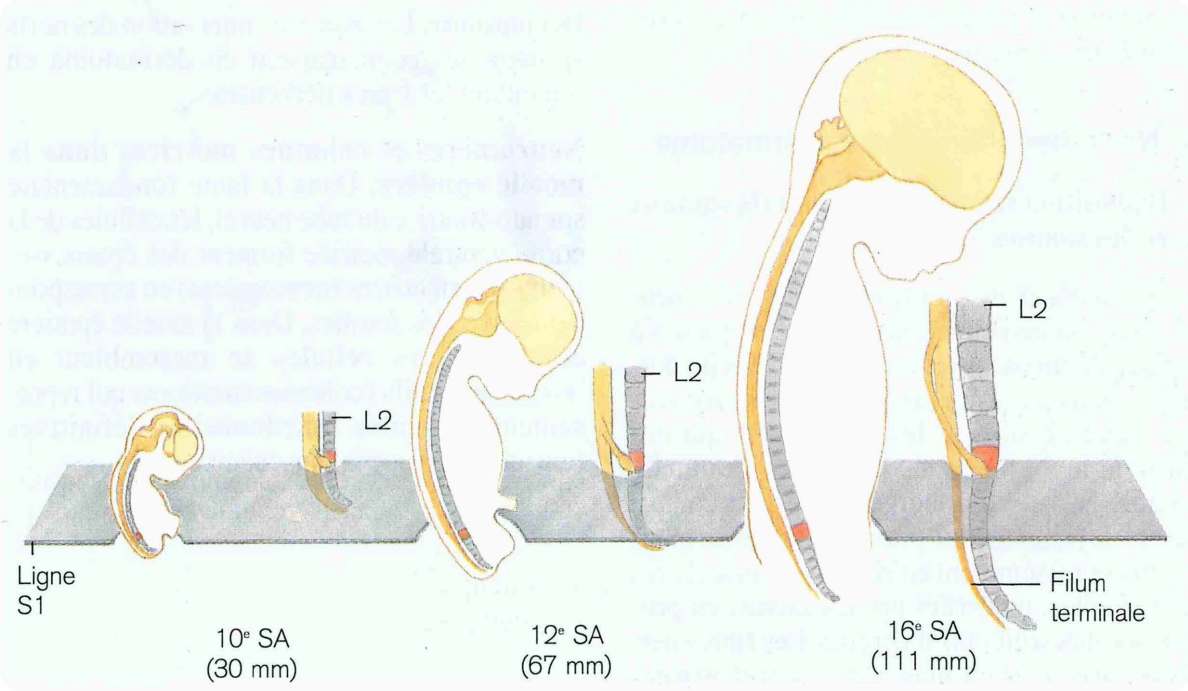


FIG. — Croissance relative moelle épinière

LA LIGNE PRIMITIVE ET LE FULCRUM CARDIAQUE

Le lieu le plus précoce identifiable est la ligne primitive.

La notochorde se termine au niveau de S2. L'espace entre S2 et l'extrémité de la ligne primitive contient le vestige de la ligne primitive.

Le **fulcrum embryonnaire** du cœur est sur le coccyx.

Le cœur se met alors dans une posture plutôt **diastolique**, cherchant de l'énergie et du volume. Il redescend dans son mouvement.

Le cœur présente également un fulcrum, c'est-à-dire un point d'origine, qu'il peut manifester différemment.

MOUVEMENTS ET STRUCTURES CARDIAQUES

Un mouvement s'établit entre le **cerveau**, avec la **céphalisation**, et le cœur, la **cardialisation**, permettant leur rencontre.

Au même moment, les deux tubes endocardiques se rencontrent sur la ligne médiane. Suit le **looping** du cœur, puis la mise en place du **sinusoïde cardiaque** et de la **crosse aortique**, avec les gros vaisseaux.

L'**axe cave** sert de repère.

Il est important d'observer si le cœur s'exprime sur un plan systolique ou diastolique. Facialement, il recherche plus la diastole ou la systole.

Par rapport à l'iliaque, il cherche beaucoup plus l'**horizontalité**, ce qui indique un mouvement diastolique. Nous pouvons aller jusqu'à rechercher le **pouls aortique**.

DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL ET CARDIAQUE

Nous intégrerons progressivement le développement du cerveau par rapport au mouvement développemental.

Le premier mouvement de développement du cerveau était l'**expansion**. Cette expansion dépendait de l'**axe longitudinal** ou de l'**axe mésentérique**. Elle dépend de l'intégration vitelline, dont le vestige se retrouvera sur l'axe mésentérique.

Ensuite, un autre niveau important pour la nutrition est le système entre la **rate** et le **foie**, avec le retour vers le cœur via la **veine cave**. Puis, l'information aortique va se manifester par quatre ou deux portes d'entrée : carotidienne, au-dessus, en dessous, vertébrale.

Nous intégrons ainsi le développement du cerveau avec le cœur et le système mésentérique. En travaillant sur le cerveau, on observe quel champ doit s'ouvrir. On peut affiner les perceptions pour déterminer les zones à travailler, par exemple sur le système carotidien par rapport au cœur.

Ceci peut être fait en donnant de simples points d'appui, qu'ils soient des fulcrums embryonnaires ou des points d'appui dans la construction, pour redynamiser la force de régénération.

Un fulcrum est un point d'émergence. Toute la force de développement, comme l'intégration de la **vésicule vitelline** dans une artère (un vestige de la voie développementale et non un fulcrum embryonnaire), se situe entre le fulcrum et la finalité.

Nous commençons à percevoir le jeu dans lequel nous allons nous engager, car nous travaillerons sur des artères spécifiques. L'objectif est de redonner la **pleine homéostasie**, la pleine vitalité, la pleine santé.

ORIGINE DU FULCRUM ET VAGUE MÉSODERMIQUE

Je toucherai l'origine de son fulcrum, qui se retrouve de façon indirecte au niveau coccygien, puis qui s'intégrera petit à petit dans son système par le mouvement développemental du **manotococcus**, cette vague avec cette aspiration au niveau du mésoderme.

C'est une information qui restructure, redynamise, redonne la force au tissu, redonne la fonction.

Le développement des forces embryonnaires permet le développement de la fonction principale du système.

LE RÔLE CENTRAL DU DIAPHRAGME

Le grand maître pour tout cela sera le **diaphragme**. Il s'agit de bien se poser sur ce diaphragme avec trois niveaux :

- **Cavité amniotique** sur le plan transversal
- **Thoracique**
- **Abdominale**

Cette intégration du cœlome, et en même temps l'intégration du cerveau, du cœur, du diaphragme, la partie postérieure du péritoine, pour revenir sur le **périnée** et redonner par cette bascule du foie toute la fermeture de ma ligne blanche, qui donnera toute l'information **urogénitale**.

LA LIGNE BLANCHE ET LE SYSTÈME UROGÉNITAL

C'est ainsi que cela va se former. La **ligne blanche** représente l'intégration complète du plan urogénital, c'est son histoire finale.

Sur cette ligne blanche, nous pourrons rechercher des concentrations de temps cristallisées, car c'est une ligne de probabilité en rapport avec l'**érythrocyte**, la formation des globules, donc un futur, où le plan de la **copula** est aussi ton futur.

Au moment de la sortie, l'étirement se produit, et c'est ainsi que tout le système génital externe et interne va s'intégrer sur ce plan de la ligne blanche antérieure. Elle se termine pour reconstruire.

Sur un plan des globules, l'**érythrocytose** ou la **gonocytose** avancent. À un moment donné, l'embryon fait un mouvement. Il y a une ligne d'initiation dans la vie. Au moment de la naissance, il faut ouvrir cette ligne, la ligne blanche, et s'initier à la vie.

FULCRUMS EMBRYONNAIRES ET SYSTÈME ARTÉRIEL

L'idée sera de redonner les justes **fulcrums embryonnaires**. Le système artériel doit être vu comme un **octopus**.

Demain, nous détaillerons le système artériel au niveau du visage, car c'est une porte d'accès trophique au niveau du cerveau. Il faudra comprendre le développement du système carotidien et du système vertébral.

Ces deux systèmes, avec toute l'information sur le **polygone de Willis** et les **artères cérébrales** antérieure, moyenne, postérieure, ainsi que les sinus ou les soupapes (de Brechet ou de Thierry Goïdienne, etc.), sont des espaces d'équilibre.

ÉQUILIBRE VASCULAIRE CÉRÉBRAL

Nous avons besoin d'un équilibre entre l'apport vasculaire et le retour veineux. On sait maintenant qu'il existe un **système lymphatique** dans le cerveau.

Pour éliminer les surplus, certains peuvent avoir une **congestion lymphatique** ou veineuse au niveau du cerveau. On le constate chez les personnes un peu gonflées, un peu œdémateuses. Le retour ne se fait pas.

Un travail de rééquilibrage sur le plan veineux est alors nécessaire, que ce soit au niveau de la **veine cave supérieure** ou inférieure. Cela est important pour éviter les congestions, notamment au niveau des oreilles, et tout ce qui ne peut s'évacuer.

POSTURE THÉRAPEUTIQUE

Je me positionne bien au niveau du coccyx et du cœur. On peut visualiser l'**angle de Louis**, le tronc vasculaire de type aortique pulmonaire.

Le cœur est sur l'**axe longitudinal**. Seule une partie de lui est dilatée vers la gauche, avec une phase de développement sur sa pointe du cœur à gauche.

Vous vous positionnerez sur le plan longitudinal du cœur. En donnant un fulcrum ici et un point d'appui sur le cœur, mon attention est dans l'espace, neutre, et nous laissons le système s'organiser.